LEGEMIDLER VED MIGRENEBEHANDLING

Anfallsbehandling og profylaktisk behandling — dosering, maks utlevering og refusjon

Maksimal døgndose iht. preparatomtale · Praktisk maks utlevering for 3 måneders forbruk · Utlevering baseres alltid på doseringen oppgitt på resepten

Triptaner — 5-HT$_{1B/1D}$-agonister · Anfallsbehandling **CGRP-antagonister (gepanter) · Anfall og/eller profylakse**

⚕ HØY ELLER UVANLIG DOSERING

Dersom doseringen fremstår som høyere eller hyppigere enn ordinært, bør det kontrolleres om resepten er rekvirert av en spesialist. Eventuelt vurder kontakt med kunde eller rekvirent for å avklare.

⚠ HOVEDREGEL

Anfallsbehandling: maks 10 behandlingsdager/måned
3 måneder = døgndose × 10 × 3 = **døgndose × 30**
Vydura profylakse: annenhver dag ≈ 45 tabl. / 3 måneder
Aquipta: 1 tabl. daglig = 90 tabl. / 3 måneder

PREPARAT (VIRKESTOFF)	MERKENAVN (EKSEMPLER)	FORMULERING	MAKS DØGNDOSE IHT. PREPARATOMTALE	DOSERINGSPRINSIPP ENKELTDOSE = ETT INNTAK	MAKS UTLEVERING 3 MND (10 BEH.DAGER/MÅNED)	KOMMENTAR / REFUSJON
▸ TRIPTANER — 5-HT$_{1B/1D}$-AGONISTER · ANFALLSBEHANDLING						
Sumatriptan *sumatriptan*	Imigran, Sumatriptan Advanz Pharma, Sumatriptan Aristo, Sumatriptan Bluefish, Sumatriptan SUN, Sumatriptan Teva	💊 Tablett 🔵 Nesespray 💉 Injeksjon s.c.	**300 mg peroralt** 50–100 mg per dose **40 mg nesespray** 20 mg per dose (2×) 12 mg s.c. (6 mg per dose)	Kan gjentas etter ≥ 2 timer Maks **2 enkeltdoser** per 24 t.	**180 tabletter** (50 mg) **90 tabletter** (100 mg) **60 enheter** (spray/inj.) Beregnet separat per formulering. NB: maks døgndose gjelder samlet.	Vanlig kilde til overforbruk. Maks døgndose inkluderer alle formuleringer.
Rizatriptan *rizatriptan*	Maxalt, Maxalt Rapitab	💊 Tablett 💊 Smeltetablett	**20 mg** 10 mg — 2 ganger daglig	Kan gjentas etter ≥ 2 timer Maks **2 enkeltdoser** per 24 t.	**60 tabletter** = maks 20 doser/måned	Lett å overskride månedsgrensen.
Zolmitriptan *zolmitriptan*	Zomig, Zomig Rapimelt, Zomig Nasal	💊 Tablett 💊 Smeltetablett 🔵 Nesespray	**10 mg** 2,5–5 mg per dose	Kan gjentas etter ≥ 2 timer Maks **2 enkeltdoser** per 24 t.	**60 enheter totalt** = maks 20 doser/måned (alle formuleringer samlet)	Nesespray + tablett summeres — risiko for overdosering. Startdose 2,5 mg; 5 mg kan vurderes ved utilstrekkelig effekt ved senere anfall.
Eletriptan *eletriptan*	Relpax, Eletriptan Pensa	💊 Tablett	**80 mg** 40 mg — 2 ganger daglig	Kan gjentas etter ≥ 2 timer Maks **2 enkeltdoser** per 24 t.	**60 tabletter** = maks 20 doser/måned	40 mg — 2 ganger daglig er vanligst.
Almotriptan *almotriptan*	Almogran, Almotriptan Orifarm	💊 Tablett	**25 mg** 12,5 mg — 2 ganger daglig	Kan gjentas etter ≥ 2 timer Maks **2 enkeltdoser** per 24 t.	**60 tabletter** = maks 20 doser/måned	Effekt tilsvarende andre triptaner.
Naratriptan *naratriptan*	Naramig, Naratriptan Orifarm	💊 Tablett	**5 mg** 2,5 mg — 2 ganger daglig	Kan gjentas etter ≥ **4 t**. Maks **2 enkeltdoser** per 24 t.	**30 tabletter** = maks 10 doser/måned	Lav bivirkningsprofil — kan gi hyppigere bruk. Vær ekstra oppmerksom.
▸ CGRP-ANTAGONISTER (GEPANTER) · ANFALL OG/ELLER PROFYLAKSE						
Rimegepant *rimegepant* **ANFALL + PROFYLAKSE**	Vydura	💊 Smeltetablett (orodispersibel)	**75 mg (anfall)** 1 dose per 24 t, ved behov **75 mg (profylakse)** Annenhver dag, fast	**Anfall:** 1 tabl. ved behov, maks 1×/dag **Profylakse:** 1 tabl. annenhver dag NB: kan brukes som anfallsbehandling på ikke-planlagte profylaksedager	**30 smeltetabletter (anfall)** = maks 10 doser/måned **45 smeltetabletter (profylakse)** ca. 15 smeltetabletter/måned (annenhver dag)	Godkjent for **både** anfall og profylakse. **§2 ANFALL — FORHÅNDSGODKJENT** **PROFYLAKSE — §3 INDIVIDUELT VEDTAK** §2-vilkår: svikt/intoleranse/KI mot ≥ 3 triptaner
Atogepant *atogepant* **KUN PROFYLAKSE**	Aquipta	💊 Tablett (10 mg / 60 mg)	**60 mg** 1 gang daglig 10 mg daglig ved sterke CYP3A4- eller OATP-hemmere	1 tablett daglig Fast forebyggende behandling — ikke ved behov	**90 tabletter / 3 mnd** = daglig bruk	**Kun forebyggende** — ikke anfallsbehandling. **§3 INDIVIDUELT VEDTAK (HELFO)** Kontroller at vedtak foreligger og er gyldig (12 mnd).

Utlevering for 3 måneder hjemlet i Legemiddelforskriften § 5-2 · Vydura profylakse: annenhver dag ≈ 45 tabl./3 måneder · Aquipta: daglig = 90 tabl./3 måneder

Felleskatalogen (preparatomtaler) · Helsedirektoratet retningslinje hodepine 2021 · RELIS · Helfo.no

VEILEDNING TIL TABELLEN — LEGEMIDLER VED MIGRENEBEHANDLING

Supplement til tabellen over maksimal døgndose og praktisk maks utlevering for 3 måneders forbruk

Σ SLIK BEREGNER DU MAKS UTLEVERING

Utgangspunktet er **døgndosen oppgitt på resepten**. For anfallsbehandling kan denne dosen brukes **maks 10 ganger per måned**:

```
3 måneders forbruk = døgndose × 10 × 3 = døgndose × 30
```

Antall enheter (tabletter, sprayer eller injeksjoner)

Vydura – profylakse: Annenhver dag = ca. 15 smeltetabletter/måned = **45 tabl. per 3 måneder**
Aquipta: Daglig dosering = **90 tabl. per 3 måneder**

Utlevering utover 3 måneder krever særlige årsaker og bør dokumenteres (Legemiddelforskriften § 5-2).

✓ VIKTIGE KONTROLLPUNKTER

- Sjekk total bruk av **alle** anfallsmidler pasienten bruker — ikke kun én type.
- >10 behandlingsdager/måned gir økt risiko for **medikamentoverforbrukshodepine (MOH)**.
- Bruk av **flere** migrenepreparater samtidig øker risikoen ytterligere.
- Spør pasienten ved større uttak: *«Hvor ofte bruker du dette?»*
- Vydura: avklar om resepten er skrevet for **anfall eller profylakse** — påvirker refusjon og mengde.
- Dokumenter vurderingen og eventuell kontakt med rekvirent.

! VIKTIG Å HUSKE

- Følg alltid doseringen som står på resepten.
- Dersom doseringen virker feil eller ikke samsvarer med anbefalingene, kontakt kunden og innhent ny resept.
- Ved hyppig bruk (>10 behandlingsdager/måned) — vurder om forebyggende behandling bør anbefales.
- Naratriptan: lavere bivirkningsprofil kan gi hyppigere bruk — vær ekstra oppmerksom på utleveringshistorikk.
- Vydura kan brukes som anfallsbehandling på dagene pasienten *ikke* tar profylaksedosen.

→ TIPS FOR BEDRE RESEPTKONTROLL

- Se etter mønstre i utleveringshistorikken over tid — hyppige uttak eller kombinasjonsbruk er varseltegn.
- Vurder intervensjon og kontakt med rekvirent dersom bruksmønsteret tilsier overforbruk.
- Informer pasienten om risikoen ved overbruk og fordelen av forebyggende behandling.
- Aquipta-resepter: individuelt HELFO-vedtak (§3) er alltid påkrevd — kontroller gyldighet og tidsbegrensning (12 mnd).
- Vydura-profylakse: §3-vedtak må foreligge — §2 gjelder *kun* anfallsbehandling.

§ REFUSJONSOVERSIKT — PER APRIL 2026

PREPARAT	ANFALLSBEHANDLING	FOREBYGGENDE BEHANDLING	VILKÅR OG MERKNADER
TRIP	✓ §2 forhåndsgodkjent	— ikke aktuelt	Direkte blåresept. Ingen søknad nødvendig.
Vydura rimegepant	✓ §2 forhåndsgodkjent	§3 individuelt vedtak (HELFO)	§2-vilkår anfall: svikt/intoleranse/KI mot ≥ 3 triptaner. Profylakse: separat HELFO-vedtak (§3) påkrevd.
Aquipta atogepant	— ikke indikasjon	§3 individuelt vedtak (HELFO)	Kronisk migrene (≥15 hodepinedager/måned). Søknad fra spesialist i nevrologi eller lege ved offentlig sykehus. Vedtak tidsbegrenset 12 mnd — kontroller gyldighet ved utlevering.

Kilder: Felleskatalogen (preparatomtaler) · Nasjonal faglig retningslinje for hodepine, Helsedirektoratet 2021 · RELIS – Migrene · Legemiddelforskriften § 5-2 · Helfo.no (sist faglig endret nov. 2024)